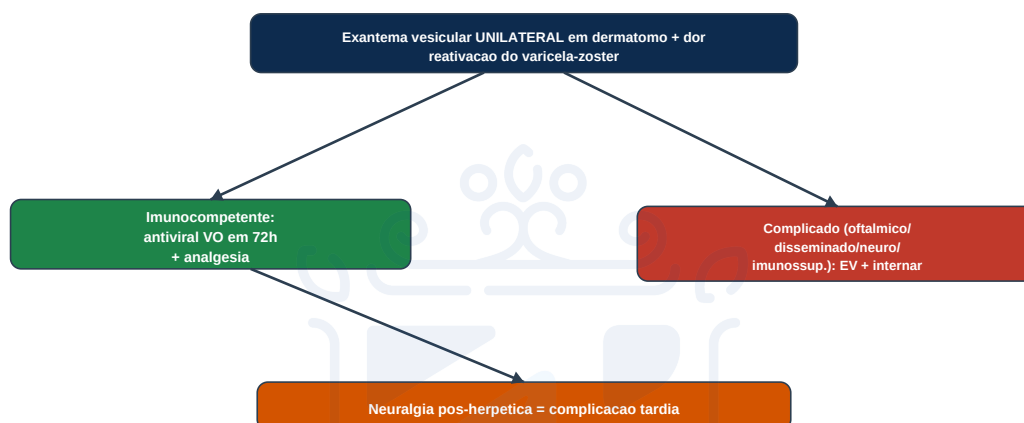


HERPES ZOSTER — ANTIVIRAL EM 72h

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

ZOSTER — VESÍCULAS EM DERMÁTOMO -> ANTIVIRAL



DEFINIÇÃO E MANIFESTAÇÕES

REATIVAÇÃO DO VARICELA-ZOSTER

- Reativação da infecção latente pelo vírus varicela-zoster; principal fator de risco é a IDADE (aumenta após os 50 anos); imunossuprimidos mais suscetíveis
- Achado clássico: exantema VESICULAR UNILATERAL, em 1-2 dermatômos contíguos; vesículas tornam-se crostosas em 7-10 dias (imunocompetentes)
- Sintoma mais comum: DOR local (neurite aguda), frequentemente precedendo as lesões (pode haver prurido prodromico)
- Zoster SINE HERPETE: reativação só com dor, sem lesão cutânea (diagnóstico por PCR)
- Formas especiais: herpes zoster OFTÁLMICO (V1), meningite asséptica, mielite, encefalite, síndrome de Ramsay Hunt

HZ COMPLICADO / RED FLAGS

TRATAMENTO EV / INTERNAÇÃO

- Imunocomprometidos (HIV/CD4 baixo, transplantados, quimioterapia ativa)
- Acometimento de MAIS DE DOIS dermatômos (zoster disseminado) ou visceral
- HZ OFTÁLMICO (V1) — risco de necrose retiniana aguda/perda visual: avaliação oftalmológica urgente
- Complicações neurológicas: meningite/encefalite, mielite, Ramsay Hunt
- Necessidade de aciclovir EV (incapacidade de VO), infecção secundária grave (celulite/seps), dor intratável

DIAGNÓSTICO

CLÍNICO (PCR SE ATÍPICO)

- Diagnóstico CLÍNICO nas formas típicas (exantema vesicular unilateral + dor em faixa)
- PCR em material das vesículas (ou liquor) nas formas atípicas/imunossuprimidos ou zoster sine herpete
- Suspeita de meningite por VZV: PCR no liquor e/ou IgG anti-VZV no LCR (razão soro/liquor reduzida sugere atividade no SNC)
- Principal diferencial: herpes simples (lesões em locais atípicos, esportes de contato)
- HZ oftálmico exige avaliação oftalmológica

TRATAMENTO ANTIVIRAL E DA DOR

Rx ANTIVIRAL PRECOCE

Antiviral idealmente em até 72h da primeira lesão (imunocompetentes); considerar após 72h se novas lesões, complicações ou alto risco (ex.: > 65 anos, V1)

Opções VO: Aciclovir, Valaciclovir ou Famciclovir; NÃO usar antiviral tópico (sem benefício)

Imunocomprometidos ou complicações neurológicas graves: ACICLOVIR EV em regime hospitalar

HZ oftálmico: antiviral sistêmico + avaliação oftalmológica (tratamento tópico/intraocular conforme necessário)

Dor AGUDA: analgésicos comuns e AINE; opioide fraco (tramadol) se dor intensa

NEURALGIA PÓS-HERPÉTICA: tópicos (lidocaína/capsaicina), gabapentinóides, tricíclicos, opioides — combinação é mais eficaz (cautela em idosos)

PREVENÇÃO, ISOLAMENTO E NEURALGIA

VACINA E COMPLICAÇÃO TARDIA

- VACINA recombinante inativada (Shingrix) é a principal prevenção (eficácia > 90%, reduz neuralgia); contraindicação absoluta apenas alergia aos componentes; pode ser usada em imunocomprometidos
- Intervalos: >= 6 meses após um episódio de HZ; >= 2 meses após outra imunização para HZ
- Neuralgia PÓS-HERPÉTICA: dor que persiste > 90 dias após o exantema (até metade dos pacientes), com alodinia/hiperalgesia
- Isolamento: imunocompetentes -> precaução de contato com lesões cobertas; imunocomprometidos -> contato + respiratório
- Encerrar isolamento após todas as lesões em crosta

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com herpes zoster em ____ (dermatomo/oftálmico/dissemiado); início há ____ horas/dias.
- Sinais/sintomas: vesículas ____, dor intensa ____, febre ____, alteração visual ____, sinais meníngeos ____.
- Critério de gravidade: ____ (oftálmico/dissemiado/imunossupressão/neurológico/aciclovir EV/dor intratável).
- Conduta: antiviral ____ (VO/EV) iniciado às ____, analgesia ____; encaminhado a infectologia / OFTALMOLOGIA urgente (se V1).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o prazo ideal para iniciar o antiviral no herpes zoster em paciente imunocompetente?

- A) Até 72 horas do início das lesões
- B) Após 2 semanas
- C) Apenas quando houver crostas
- D) Somente se houver febre
- E) Não há benefício em antiviral

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que o herpes zoster oftálmico (V1) é uma situação de alerta?

- A) Risco de surdez
- B) Risco de necrose retiniana aguda e perda visual — exige avaliação oftalmológica urgente
- C) Risco de hepatite
- D) Risco de pancreatite
- E) Não tem relevância

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Como se define a neuralgia pós-herpética?

- A) Dor durante as primeiras 48h
- B) Dor que persiste por mais de 90 dias após o início do exantema
- C) Prurido leve transitório
- D) Dor apenas no surgimento das vesículas
- E) Cefaleia isolada

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é a principal forma de prevenção do herpes zoster?

- A) Antibiótico profilático
- B) Vacina recombinante inativada (Shingrix)
- C) Antiviral tópico contínuo
- D) Corticoide
- E) Imunoglobulina mensal

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual classe de fármacos é usada no manejo da neuralgia pós-herpética?

- A) Apenas antivirais
- B) Gabapentinóides, tricíclicos, tópicos (lidocaína/capsaicina) e opioides
- C) Apenas antibióticos
- D) Corticoide tópico isolado
- E) Antifúngicos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: A

O antiviral deve ser iniciado idealmente em até 72h do surgimento das lesões em imunocompetentes; após esse prazo, considera-se se houver novas lesões, complicações ou alto risco.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O HZ oftálmico (V1) tem risco de necrose retiniana aguda e perda visual, exigindo antiviral sistêmico e avaliação oftalmológica urgente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A neuralgia pós-herpética é a dor que persiste por mais de 90 dias após o início do exantema, podendo cursar com alodinia e hiperalgisia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A vacina recombinante inativada (Shingrix) é a principal prevenção, com eficácia > 90% e redução da neuralgia pós-herpética; pode ser usada em imunocomprometidos.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A neuralgia pós-herpética é manejada com gabapentinóides, tricíclicos, agentes tópicos (lidocaína/capsaicina) e opioides; a combinação é mais eficaz, com cautela em idosos.

SM24
Suporte ao Plantão Médico